Ces notes ont pour seule vocation d'être utilisées par les étudiants dans le cadre de leur cursus au sein de l'ULiège.

Aucun autre usage ni diffusion n'est autorisé, sous peine de constituer une violation de la loi du 30 juin 1994 sur le droit d'auteur.

TROUBLES ANXIEUX
Partie I

Professeure G. SCANTAMBURLO

TROUBLES ANXIEUX

Partie I	TROUBLE PANIQUE	TROUBLE ANXIEUX GÉNÉRALISÉ	TROUBLE PHOBIQUE
Partie II	ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE	TROUBLE DE L'ADAPTATION	
Partie III	TROUBLE OBSESSIONNEL COMPULSIF		

TROUBLES ANXIEUX

Objectifs pédagogiques

- Pour chaque trouble
  - Connaître les données épidémiologiques
  - Connaître les étapes du diagnostic en articulant les algorithmes décisionnels, la symptomatologie et le diagnostic différentiel
- Dresser les possibilités thérapeutiques, en intégrant les mécanismes étiopathogéniques

TROUBLES ANXIEUX

Objectifs pédagogiques

- Connaître
  - la distinction entre stress, anxiété et peur
  - les manifestations cliniques de l'anxiété
  - la distinction entre anxiété et trouble anxieux
  - les caractéristiques des troubles anxieux

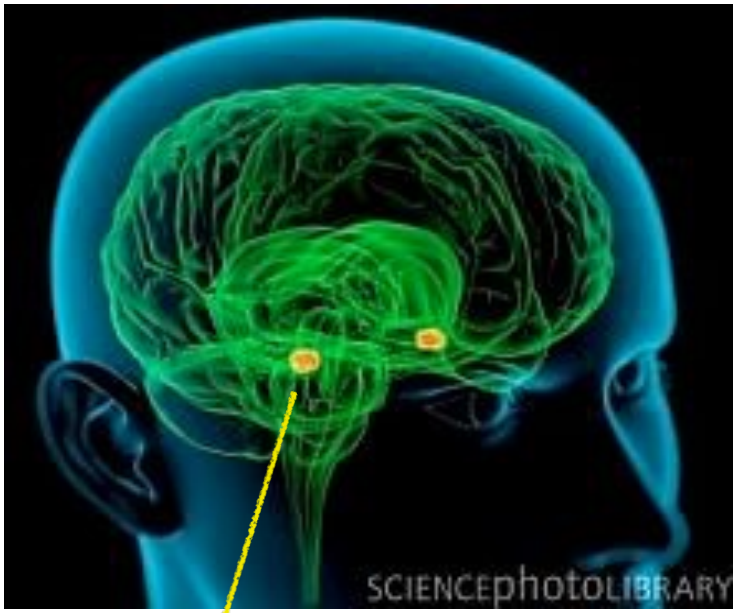
1. **C**ontrôle faible
2. **I**mprévisibilité
3. **N**ouveauté
4. **E**go menacé

Réponse hormonale à une MENACE réelle ou perçue

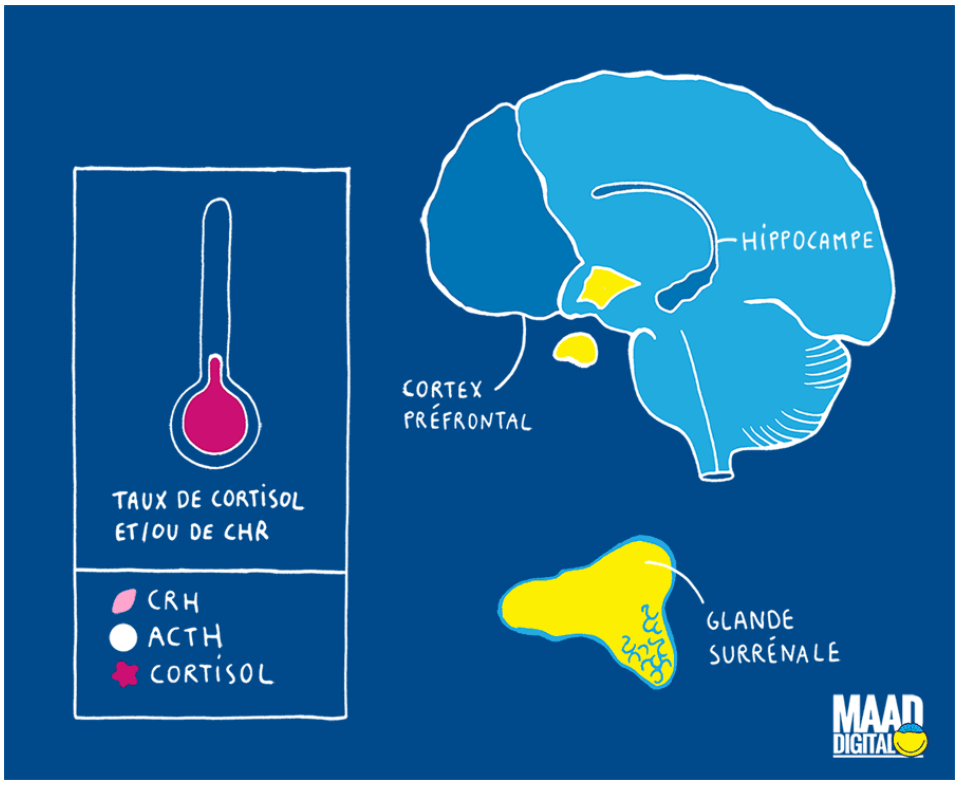
TROUBLES ANXIEUX

LE STRESS

- Résultat de l'interaction entre le sujet et son environnement
- Etat de divergence, d'inadéquation, entre les demandes perçues et l'idée des possibilités de réponses
- La réaction au stress = sentiment de perte de contrôle de la situation
- Lorsque la réaction est intense, durable ou chronique, elle s'accompagne d'une souffrance et est susceptible d'entraîner des pathologies


SCIENCEphotoLIBRARY

AMYGDALE


TAUX DE CORTISOL
ET/OU DE CHR
CRH
ACTH
CORTISOL
HIPPOCAMPE
CORTEX
PRÉFRONTAL
GLANDE
SURRÉNALE
MAAD
DIGITAL

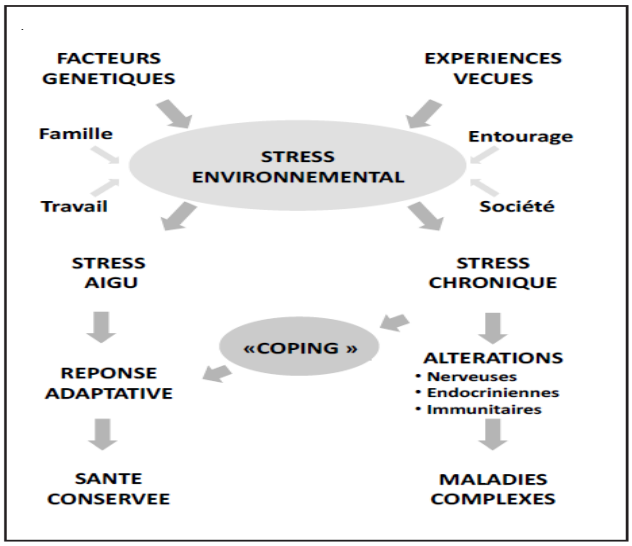


Figure 3. Rôle de la prédisposition génétique et des expériences vécues dans les réponses au stress environnemental. En cas de stress chronique, l'absence de « coping » provoque des altérations neuro-endocrino-immunitaires susceptibles d'induire diverses maladies complexes.

G. Scantamburlo - ULiège

LA PEUR est suscitée face à une menace immédiate dans l'environnement

L'ANXIETE, c'est l'anticipation d'une menace imaginée

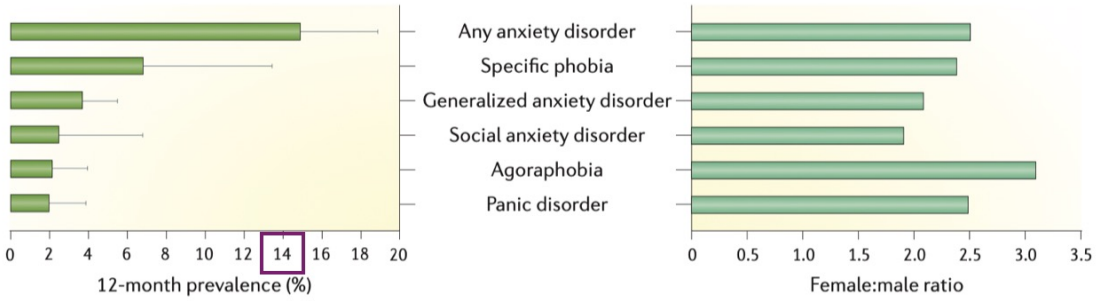
TROUBLES ANXIEUX

Manifestations cliniques de l'anxiété

Symptômes physiques	Respiratoires Cardiovasculaires Neurovégétatifs Digestifs
Symptômes psychiques	Cognitions catastrophistes (« peur de mourir », « peur de devenir fou »)
Symptômes comportementaux	Agitation psychomotrice Sidération

TROUBLES ANXIEUX

Epidémiologie



G. Scantamburlo - ULiège

TROUBLES ANXIEUX, TOC

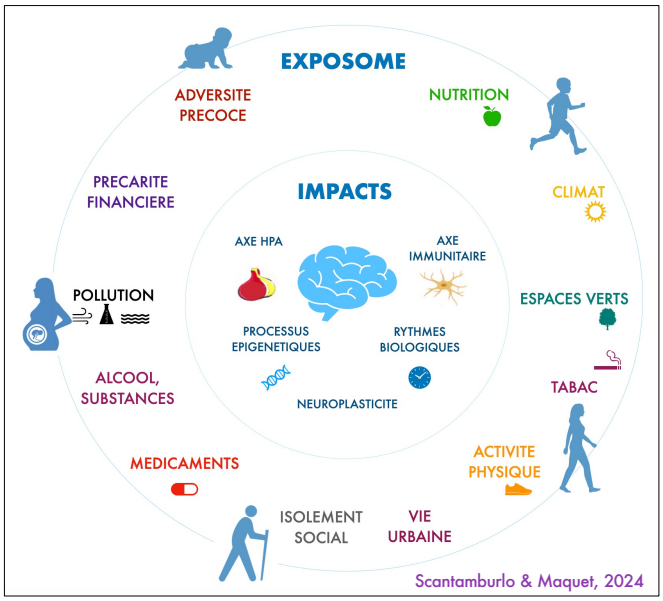
Caractéristiques cliniques principales

Phobie spécifique	▪ Peur excessive d'objets, d'animaux, de personnes ou de situations qui sont soit évités, soit supportés avec une détresse significative
Trouble anxieux généralisé	▪ Inquiétudes excessives prolongées ne se limitant pas à des circonstances particulières - anxiété flottante
Anxiété sociale	▪ Peur d'être observé ou évalué négativement par les autres dans des situations de performance sociale
Trouble panique	▪ Attaques de panique récurrentes et inattendues ▪ Le pic généralement atteint en 10 minute (durée: 30 à 45 minutes) ▪ Patients être en danger de mort imminente pendant la crise
Trouble obsessionnel-compulsif	▪ Obsessions (pensées intrusives) et/ou Compulsions (comportements ritualisés), minimum 1h par jour

G. Scantamburlo - ULiège

Programme de formation 2025 – Tous droits réservés

TROUBLES ANXIEUX



Facteurs de risque

Tempérament inhibé, renfermé
Interactions parentales négatives
Interactions sociales négatives
Abus physiques
Abus sexuels
Maladies
Ruptures relationnelles

G. Scantamburlo - ULiège

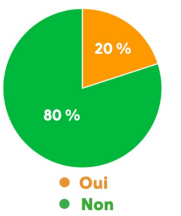
Santé mentale

N = 7127
(nov-dec 23)

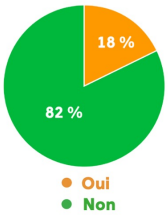
Le **projet BELHEALTH** a pour objectif d'évaluer plusieurs dimensions de la santé mentale e de les suivre au cours du temps.

Anxiété et dépression

Les participants étaient invités à indiquer dans quelle mesure (de 0 = « jamais » à 4 = « tou les jours ») ils avaient ressenti les symptômes repris dans les échelles mesurant l'anxiété[1] et l dépression[2], au cours des deux semaines précédant l'enquête.
Les scores totaux permettent d'estimer la probabilité de souffrir d'une anxiété généralisée et/ou d'un trouble dépressif.



20 % souffraient d'anxiété



18 % souffraient de dépression

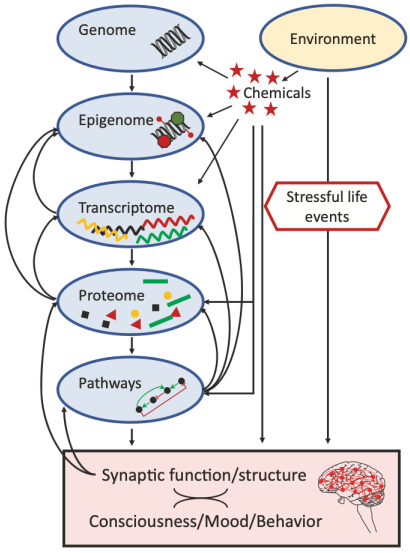
[1]L'échelle GAD-7 : Generalised Anxiety Disorder dépiste le trouble de l'anxiété généralisé.
[2]PHQ-9 scale : Patient Health Questionnaire dépiste et mesure la sévérité des symptômes.

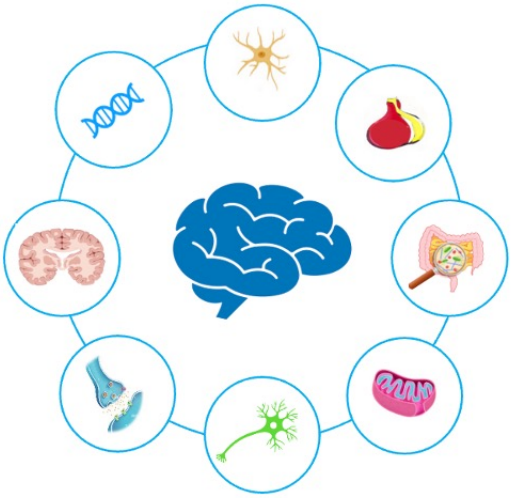
sciensano

G. Scantamburlo - ULiège

TROUBLES ANXIEUX

Mécanismes pathophysiologiques





TROUBLES ANXIEUX

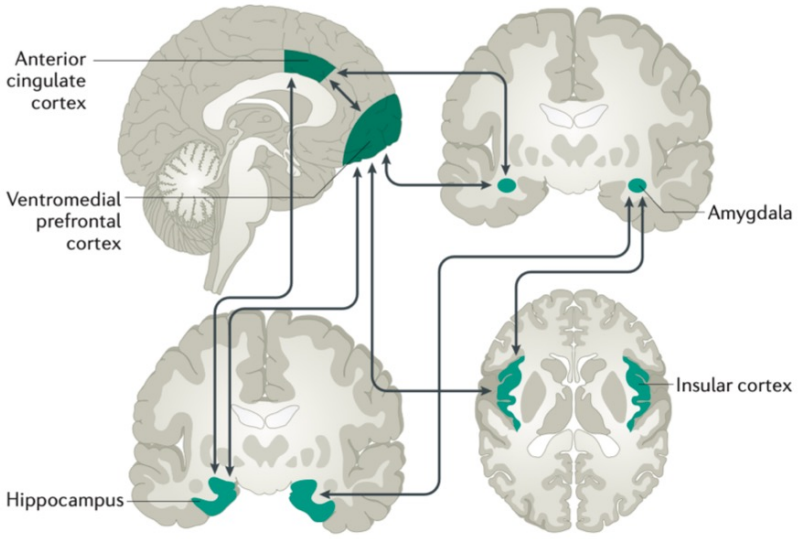
Mécanismes physiopathologiques

- Origine multifactorielle: facteurs génétiques, neurobiologiques, environnementaux
- Cognitif
  - interprétation erronée des sensations internes (« phobie interoceptive »)
    - de manière catastrophique
    - renforcement des symptômes et de l'anxiété

TROUBLES ANXIEUX

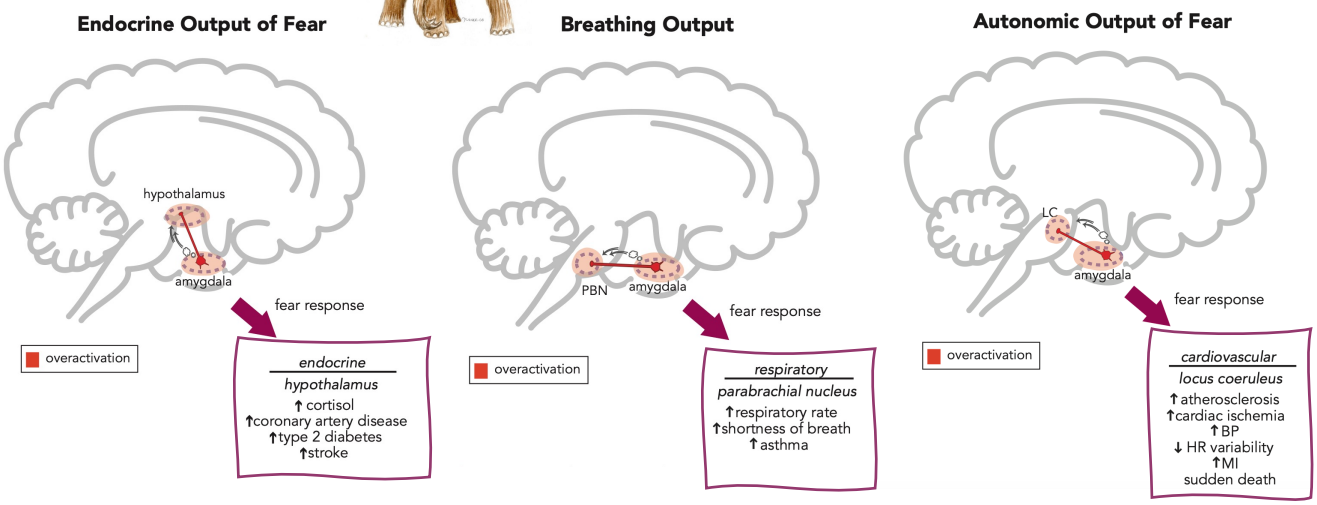
Mécanismes pathophysiologiques

DETECTION DE LA MENACE



G. Scantamburlo - ULiège

DETECTION DE LA MENACE

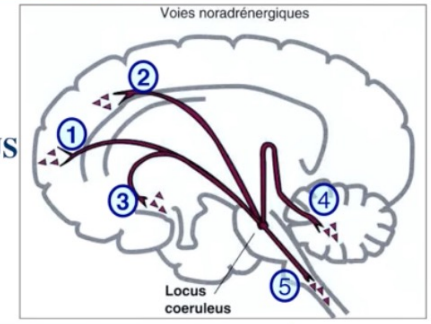


G. Scantamburlo - ULiège

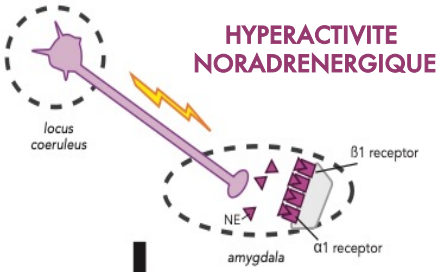
TROUBLES ANXIEUX

Mécanismes pathophysiologiques

Corps cellulaires dans le **LOCUS COERULEUS** (tronc cérébral)

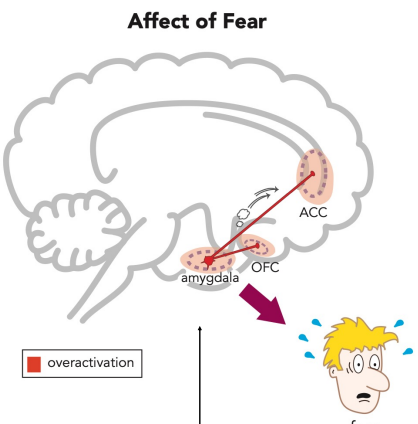


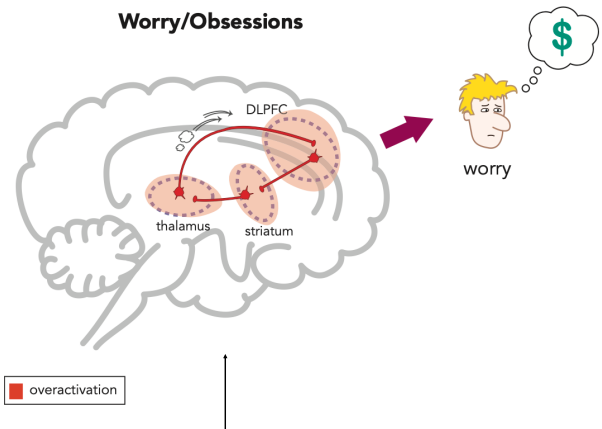
Principales projections
1. Cortex frontal
2. Cortex préfrontal
3. Cortex limbique
4. Cervelet
5. Tronc cérébral



fear/panic attacks
tremor
sweating
tachycardia
hyperarousal
nightmares

G. Scantamburlo - ULiège





5-HT
GABA
GLUTAMATE
NE
CRF/HPA

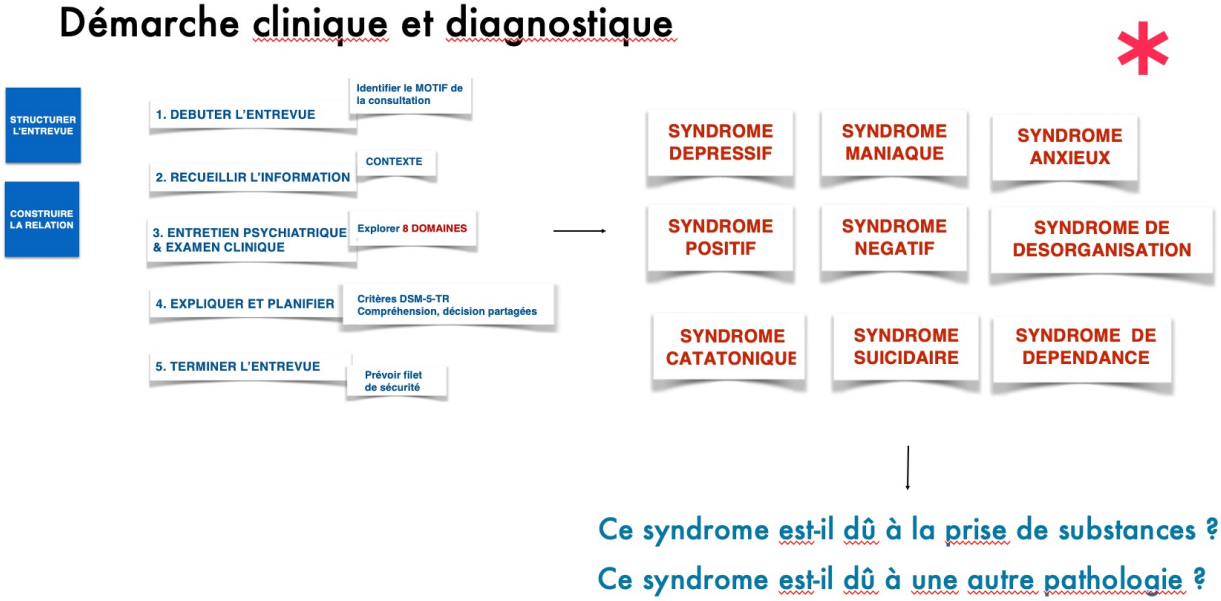
REGULATEURS

5-HT
GABA
GLUTAMATE
NE
DA

G. Scantamburlo - ULiège

CARTOGRAPHIE MINIMALE DE LA PSYCHIATRIE

Démarche clinique et diagnostique



Ce syndrome est-il dû à la prise de substances ?

Ce syndrome est-il dû à une autre pathologie ?

G. Scantamburlo - ULiège

TROUBLES ANXIEUX

Diagnostic différentiel

1. Pathologies non psychiatriques

Comme devant tout tableau psychiatrique, **les causes non psychiatriques doivent être éliminées**. Il s'agit essentiellement :

* des pathologies cardiovasculaires : syndrome coronarien aigu, hypertension artérielle, troubles du rythme, etc. ;
* des pathologies de l'appareil respiratoire : asthme, pneumopathie, etc. ;
* des pathologies neurologiques : épilepsie, sclérose en plaque, crises migraineuses, accidents ischémiques transitoires, etc. ;
* des pathologies endocriniennes : hypoglycémie, diabète, dysthyroïdie, phéochromocytome, hyperthyroïdie, syndrome de Cushing, hypoparathyroïdie, etc.

2. Intoxications par une substance psychoactive et sevrages

La prise de certaines substances doit être recherchée : amphétamines, cocaïne, hallucinogènes, cannabis, etc.

Un syndrome de sevrage doit également être éliminé (alcool, benzodiazépines, opiacés, etc.).

3. Troubles psychiatriques

G. Scantamburlo - ULiège

TROUBLES ANXIEUX

Dépister les patients à risque

« Au cours des deux dernières semaines, jusqu'à quel point avez-vous été dérangé par :

- un sentiment de nervosité, d'inquitétude ou de tension ?
- un sentiment de panique ou de peur ?
- un évitement de situations qui vous rendent anxieux ?

G. Scantamburlo - ULiège

FIGURE 3 | QUESTIONNAIRE SUR LE TROUBLE D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉ (GAD-7)

Au cours des 14 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous été dérangé(e) par les problèmes suivants ?
(Utilisez un « ✓ » pour indiquer votre réponse)

	Jamais	Plusieurs jours	Plus de la moitié des jours	Presque tous les jours
Sentiment de nervosité, d'anxiété ou de tension	0	1	2	3
Incapacité d'arrêter de vous inquiéter ou de contrôler vos inquiétudes	0	1	2	3
Inquiétudes excessives à propos de tout et de rien	0	1	2	3
Difficulté à se détendre	0	1	2	3
Agitation telle qu'il est difficile de rester tranquille	0	1	2	3
Devenir facilement contrarié(e) ou irritable	0	1	2	3
Peur que quelque chose d'épouvantable puisse arriver	0	1	2	3
Score total				

Source : Spitzer L, Williams JB, Kroenke K et coll. *GAD-7*. New York : Pfizer. Site Internet : *www.phqscreeners.com/pdfs/03_GAD-7/GAD7_French%20for%20Canada.pdf* (Date de consultation : septembre 2014). Reproduction autorisée.

TABLEAU III | DEGRÉ DE GRAVITÉ DES SYMPTÔMES D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE À L'AIDE DU GAD-7[18]

Degré de gravité	Note totale
Minime	0-4
Léger	5-9
Modéré	10-14
Grave	15-21

G. Scantamburlo - ULiège

Anxiété généralisée selon le DSM-5-TR

A. Anxiété et soucis excessifs (attente avec appréhension) survenant la plupart du temps durant au moins 6 mois concernant un certain nombre d'événements ou d'activités (tel le travail ou les performances scolaires).

B. La personne éprouve de la difficulté à contrôler cette préoccupation.

C. L'anxiété et les soucis sont associés à 3 (ou plus) des symptômes suivants (dont au moins certains symptômes présents la plupart du temps durant les 6 derniers mois) :
   1. Agitation ou sensation d'être survolté ou à bout
   2. Fatigabilité
   3. Difficultés de concentration ou trous de la mémoire
   4. Irritabilité
   5. Tension musculaire
   6. Perturbation du sommeil (difficultés d'endormissement ou sommeil interrompu agité et non satisfaisant)

D. L'anxiété, les soucis ou les symptômes physiques entraînent une détresse ou une altération cliniquement significatives du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.

E. La perturbation n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance ou d'une autre affection médicale (p. ex. : hyperthyroïdie).

F. La perturbation n'est pas mieux expliquée par un autre trouble mental.

G. Scantamburlo - ULiège

Trouble panique selon le DSM-5-TR

A. Attaques de panique récurrentes et inattendues. L'attaque de panique est une montée brusque de crainte ou de malaise intense qui atteint son acmée en quelques minutes, avec la survenue de 4 (ou plus) des symptômes suivants:

   1. Palpitations, battements de cœur ou accélération du rythme cardiaque
   2. Transpiration
   3. Tremblements ou secousses musculaires
   4. Sensations de « souffle coupé » ou impression d'étouffement
   5. Sensation d'étranglement
   6. Douleur ou gêne thoracique
   7. Nausée ou gêne abdominale
   8. Sensation de vertige, d'instabilité, de tête vide ou impression d'évanouissement
   9. Déréalisation (sentiment d'irréalité) ou dépersonnalisation (être détaché de soi)
   10. Peur de perdre le contrôle ou de devenir fou
   11. Peur de mourir
   12. Paresthésies (sensations d'engourdissement ou de picotements)
   13. Frissons ou bouffées de chaleur

A. Au moins une des attaques a été suivie par une période d'1 mois (ou plus) de l'un ou des deux symptômes suivants :
   1. Crainte persistante ou inquiétude d'autres attaques de panique ou de leurs conséquences
   2. Changement de comportement significatif et inadapté en relation avec les attaques

C. La perturbation n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance

D. La perturbation n'est pas mieux expliquée par un autre trouble mental (comme l'anxiété sociale, la phobie spécifique, le trouble obsessionnel compulsif, le trouble stress post-traumatique)

G. Scantamburlo - ULiège

Agoraphobie selon le DSM-5-TR

A. Peur ou anxiété marquées pour deux (ou plus) des cinq situations suivantes :
   1. Utiliser les transports en commun (p. ex. : voitures, bus, trains, bateaux, avions)
   2. Etre dans des endroits ouverts (p. ex. : parking, marchés, ponts)
   3. Etre dans des endroits clos (p. ex. : magasins, théâtres, cinémas)
   4. Etre dans une file d'attente ou dans une foule
   5. Etre seul à l'extérieur du domicile

B. La personne craint ou évite ces situations parce qu'elle pense qu'il pourrait être difficile de s'en échapper ou de trouver du secours en cas de survenue de symptômes de panique ou d'autres symptômes incapacitants ou embarrassants

C. Les situations agoraphobogènes provoquent presque toujours une peur ou de l'anxiété.

D. Les situations agoraphobogènes sont activement évitées, nécessitent la présence d'un accompagnant ou sont subies avec une peur intense ou de l'anxiété.

E. La peur ou l'anxiété sont disproportionnées par rapport au danger réel lié aux situations agoraphobo- gènes et compte tenu du contexte socio-culturel.

F. La peur, l'anxiété ou l'évitement sont persistants, durant typiquement 6 mois ou plus.

G. La peur, l'anxiété ou l'évitement causent une détresse ou une altération cliniquement significative du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.

H. Si une autre affection médicale est présente, la peur, l'anxiété ou l'évitement sont clairement excessifs.

I. La peur, l'anxiété ou l'évitement ne sont pas mieux expliqués par les symptômes d'un autre trouble mental (phobie spécifique anxiété sociale, trouble obsessionnel compulsif, dysmorphie corporelle, trouble stress post-traumatique.

G. Scantamburlo - ULiège

Phobie spécifique selon le DSM-5-TR

A. Peur ou anxiété intense à propos d'un objet ou d'une situation spécifique (avion, hauteurs, animaux, sang).

B. L'objet ou la situation phobogène provoque presque toujours une peur ou anxiété immédiate.

C. L'objet ou la situation phobogène est activement évité(e) ou vécu(e) avec une peur ou une anxiété intense.

D. La peur ou l'anxiété est disproportionnée par rapport au danger réel engendré par l'objet ou la situation spécifique et par rapport au contexte socioculturel.

E. La peur, l'anxiété ou l'évitement sont persistants, habituellement pendant une durée de 6 mois ou plus.

F. La peur, l'anxiété ou l'évitement causent une souffrance cliniquement significatives ou une altération marquée du fonctionnement.

G. Le trouble n'est pas mieux expliqué par un trouble panique, de l'agorapphobie, un trouble obsessionnel-compulsif, un trouble de stress post-traumatique, ou une anxiété sociale.

G. Scantamburlo - ULiège

TROUBLES ANXIEUX

Troubles phobiques: Pronostic et évolution

- Apparaissent le plus souvent entre 10 ans et 20 ans
  - suite à une expérience stressante ou humiliante
  - disparaissent ou s'atténuent à l'âge adulte
- Si persistance à l'âge adulte: évolution chronique (rémission spontanée: 20 %)

G. Scantamburlo - ULiège

Anxiété sociale (phobie sociale) selon le DSM-5-TR

A. Peur ou anxiété intenses d'une ou plusieurs situations sociales durant lesquelles le sujet est exposé à l'éventuelle observation d'autrui (interactions sociales, être observé, situations de performance).

B. La personne craint d'agir ou de montrer des symptômes d'anxiété d'une façon qui sera jugée négativement.

C. Les situations sociales provoquent presque toujours une peur ou de l'anxiété.

D. Les situations sociales sont évitées et subies avec une peur ou une anxiété intense.

E. La peur ou l'anxiété sont disproportionnées par rapport à la menace réelle posée par la situation sociale et compte tenu du contexte socioculturel.

F. La peur, l'anxiété ou l'évitement sont persistants, habituellement pendant une durée de 6 mois ou plus.

G. La peur, l'anxiété ou l'évitement causent une souffrance cliniquement significatives ou une altération marquée du fonctionnement.

H. La peur, l'anxiété ou l'évitement ne sont pas imputables aux effets physiologiques d'une substance ni à une autre affection médicale.

I. La peur, l'anxiété ou l'évitement ne sont pas mieux expliqués par une obsession d'une dysmorphophobie, un trouble panique, ou un trouble du spectre de l'autisme.

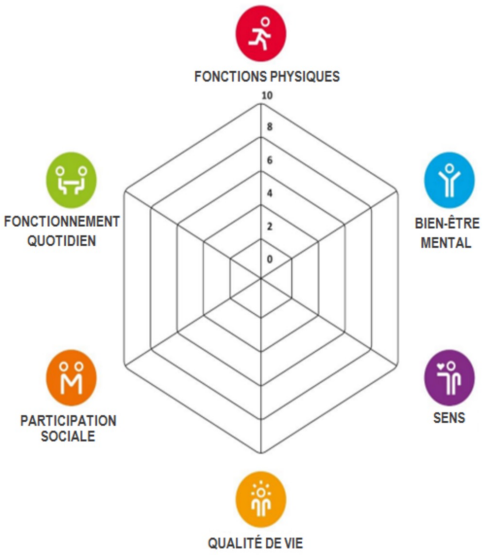
J. Si une autre affection médicale est présente, la peur, l'anxiété ou l'évitement sont clairement non liés à cette affection.

G. Scantamburlo - ULiège

TROUBLES ANXIEUX

Philosophie de soin: Approche médicale globale

- Restaurer l'Homéostasie : style de vie
- Psychothérapie: TCC
- Antidépresseurs: 1è ligne: SSRI (débuter avec demi-doses), SNRI
- Benzodiazépines: uniquement lors de crises invalidantes et sévères, max 4 semaines, risque de dépendances !
- Formes sévères à résistantes: neuromodulation



G. Scantamburlo - ULiège

TROUBLES ANXIEUX

Trouble panique: Traitements

Traitements non-pharmacologiques

- Education thérapeutique
- Psychothérapie: TCC

- arrêt des excitants : café, tabac, alcool et autres substances psychoactives
- bon équilibre alimentaire ;
- règles hygiéno-diététiques de sommeil ;
- pratiquer une activité physique régulière ;
- techniques de relaxation ;
- information sur les risques liés à l'usage des médicaments anxiolytiques (cl

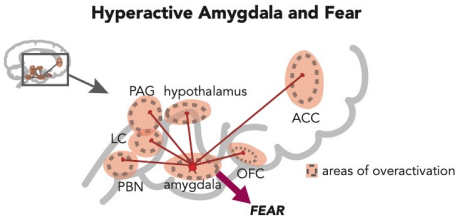
Traitements pharmacologiques

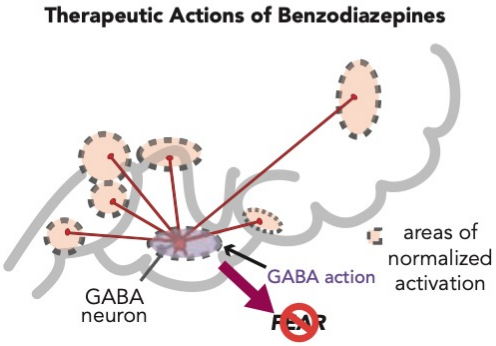
- SSRI (posologie élevée)
- IRSNA
- anxiolytiques: lors des crises

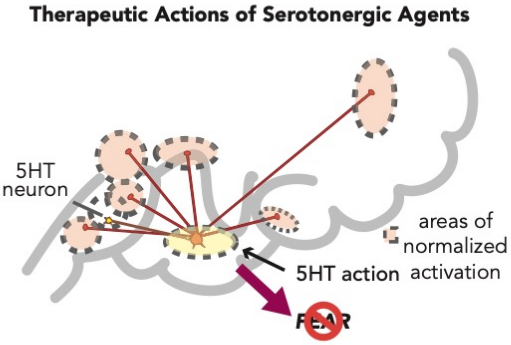
Prise en charge des comorbidités

G. Scantamburlo - ULiège

item 64e







TROUBLES ANXIEUX

Troubles anxieux généralisé: Traitements

Traitements non-pharmacologiques

- Education thérapeutique
- Psychothérapie: TCC
  - Stratégies centrées sur la gestion des émotions et des inquiétudes

Traitements pharmacologiques

- SSRI
- IRSNA
- anxiolytiques: lors des crises

Prise en charge des comorbidités

TROUBLES ANXIEUX

Troubles phobiques: Traitements

Traitements non-pharmacologiques

- Psychothérapie: TCC
  - exposition in vivo
  - restructuration cogntive

Traitements pharmacologiques

Si anxiété sociale sévère
- SSRI (posologie élevée)
- IRSNA
- anxiolytiques: lors des crises

TROUBLES ANXIEUX

Troubles phobiques: Traitements

Traitements non-pharmacologiques

- Psychothérapie: TCC
  - exposition in vivo
  - restructuration cogntive

Traitements pharmacologiques

Si phobie sociale sévère
- SSRI (posologie élevée)
- IRSNA
- anxiolytiques: lors des crises

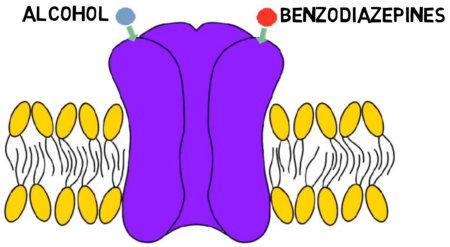
*

- Information claire doit être donnée sur
  - le caractère transitoire du traitement
  - le risque de somnolence
  - le risque d'effets indésirables majorés par la consommation d'alcool
  - Importance de diminution progressive et risque de sevrage en cas d'arrêt brutal

Indications

- Traitement symptomatique des manifestations anxieuses intenses et/ou invalidantes
- Traitement préventif dans le cadre du sevrage d'alcool
- Traitement des crises d'épilepsie

- Facilitent la transmission GABAergique et permettent de diminuer l'excitabilité neurone associée à l'anxiété



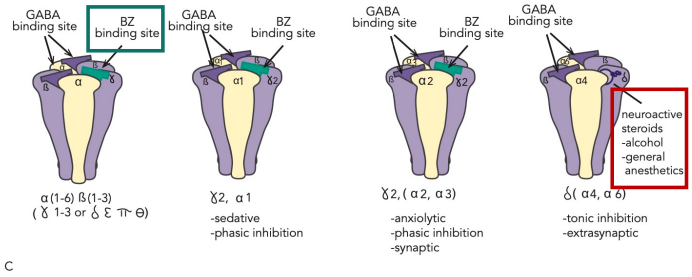
PRESCRIRE LES PSYCHOTROPES

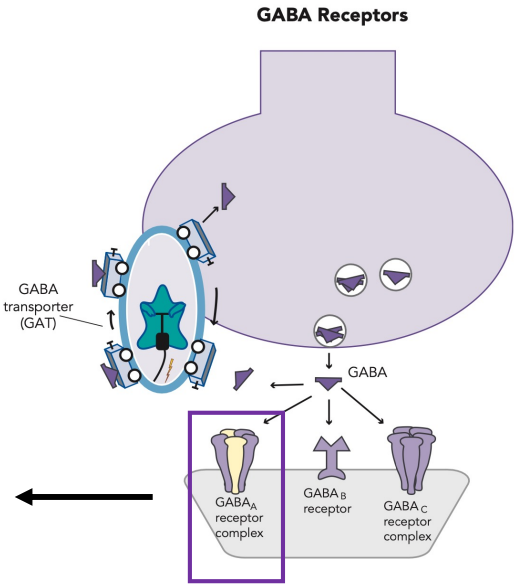
ANXIOLYTIQUES : BENZODIAZÉPINES

DÉFINITION ET MÉCANISMES D'ACTION

- Se lient au récepteur GABA-A
- Favorisent l'action du GABA
- Potentialisent l'action du GABA sur les R-GABA-A en augmentant la probabilité d'ouverture du canal en réponse au GABA et en augmentant l'affinité du GABA pour son récepteur

Principaux sous-types de Récepteurs GABAa

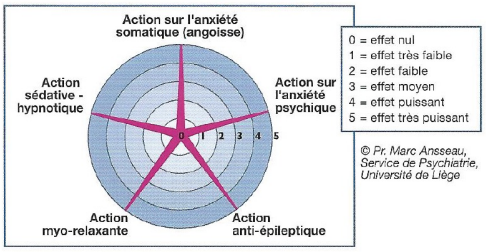




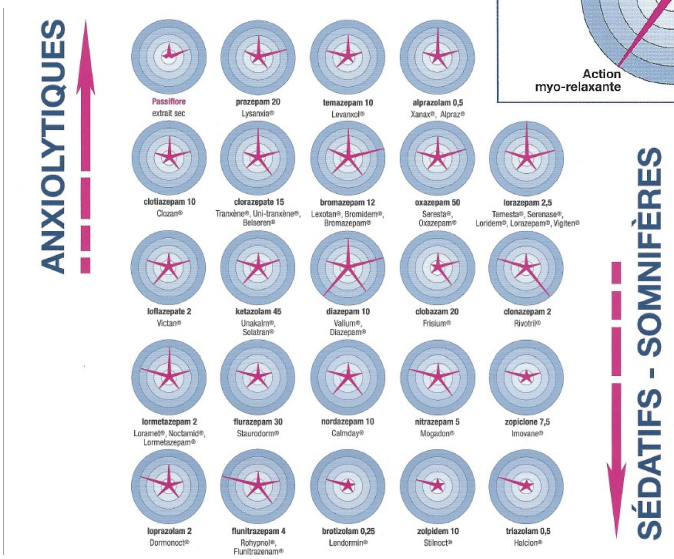
C

G. Scantamburlo - ULiège

Les étoiles d'Ansseau



1982



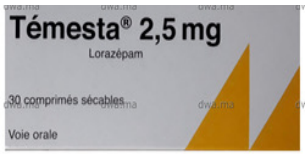
G. Scantamburlo - ULiège

Règles de prescription

- Il n'y a pas lieu d'associer 2 benzodiazepines dans les manifestations anxieuses
- Dose minimale efficace
- Veiller aux durées de prescription : maximum **4** (à 12) **semaines**
- Arrêt toujours progressif, sur quelques semaines

DEMI-VIE LONGUE

DEMI-VIE INTERMEDIAIRE



DEMI-VIE COURTE

Contre-indications

Absolues	Relatives
* Hypersensibilité connue * Insuffisance respiratoire sévère * Insuffisance hépatique sévère * Syndrome d'apnées obstructives du sommeil (non traité par pression positive continue PPC) * Myasthénie	* Grossesse et allaitement * Insuffisance rénale * Insuffisance hépatique (préférer l'oxazepam dans ce cas) * Antécédent de troubles addictifs * Antécédent de réaction paradoxale

Galénique

- Privilégier voie orale
- IM (diazépam, clorazepate dipotassique)
- IV (rarement utilisée en pratique)

Bilan pré-thérapeutique

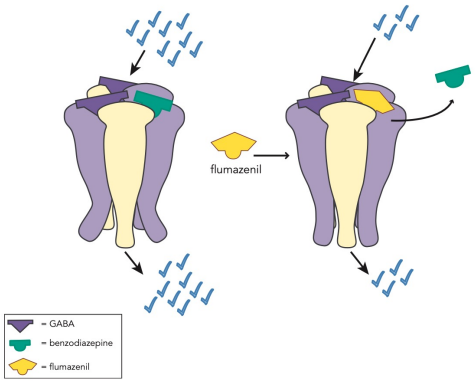
- Eliminer les contre-indications
- Anticiper interactions médicamenteuses

Surveiller la tolérance

- Rechercher effets indésirables
  - Sédation: somnolence diurne, altération de la vigilance, vertige
  - Altérations cognitives: mémoire
  - Perturbations du comportement: effets désinhibiteurs
  - Réactions paradoxales: agitation, agressivité
  - Actes automatiques amnésiques
  - Dépendances
  - Rebond de l'anxiété: à l'arrêt du traitement

Surveiller la toxicité

- En cas d'intoxication aigue et de surdosage, le pronostic vital peut être menacé
- Dépression du SNC pouvant aller jusqu'au coma
- Antidote: Flumazenil (Anexate)



Classe	Molécule	Aspects pratiques	Contre-indications absolues
Antihistaminique	Hydroxyzine (Atarax®)	* Anxiolyse moins importante qu'avec les benzodiazépines * Efficacité rapide dès la première prise * Pas de risque de dépendance * Effets anticholinergiques (sécheresse buccale, risque de rétention aigue d'urine, etc.) * Allongement de l'intervalle QT	* Hypersensibilité connue * Stade précoce de la grossesse * Glaucome à angle fermé * Adénome prostatique * QT long

PRESCRIRE LES PSYCHOTROPES

ANXIOLYTIQUES : NON-BENZODIAZÉPINES

Classe	Molécule	Aspects pratiques	Contre-indications absolues
β-bloquants	Propranolol (Avlocardyl®)	* Effet anxiolytique lié à un effet périphérique * Traitement des manifestations physiques de l'anxiété associées aux états émotionnels, de manière transitoire	* Bronchopneumopathie chronique obstructive et asthme * Insuffisance cardiaque non contrôlée * Choc cardiogénique * BAV 2 et 3 non appareillés * Angor de Prinzmetal * Maladie du sinus * Bradycardie (< 45-50 battements par minute) * Phénomène de Raynaud et troubles artériels périphériques * Phéochromocytome * Hypotension artérielle * Hypersensibilité connue * Insuffisance hépatique sévère * Prédisposition à l'hypoglycémie